



認識膽固醇

看懂 LDL 目標、飲食、藥物與追蹤

LDL 是主要治療目標；風險越高，目標訂得越低



掃描看電子版

什麼是高血脂？

LDL（壞膽固醇）過高、三酸甘油酯過高，或 HDL（好的）過低。

通常完全沒有症狀，卻會讓脂肪一點一點沉積在血管壁。

→ 心肌梗塞、腦中風、周邊動脈疾病

怎麼治療？

生活調整（基礎，人人都要做）

飲食、運動、體重、戒菸 → 降 LDL 約 5~15%

藥物治療

Statin 第一線，可降 30% 到 50% 以上

我的 LDL 目標是多少？

依 2025 台灣血脂管理臨床路徑簡化整理，實際分層請由醫師判定

風險分層	常見情況	LDL 目標 (mg/dL)
低風險	1 項危險因子，且不屬於高風險族群	< 130
中風險	至少 2 項危險因子	< 115
高風險	糖尿病、未洗腎的慢性腎病、LDL $\geq$ 190，或冠狀動脈鈣化分數 $\geq$ 400	< 100
非常高風險	已確診動脈粥樣硬化性心血管疾病 (ASCVD)	< 70
極高風險	嚴重或反覆發生的 ASCVD 等，由醫師進一步判定	< 55

危險因子常包括：高血壓、抽菸、年齡、早發性冠心病家族史、HDL 偏低、代謝症候群。

用藥常見副作用與機率

數字取自隨機對照試驗的統合分析，為大略估計值

Statin（史他汀，第一線）

肌肉痠痛 第 1 年每 1,000 人多約 11 人
肝指數上升 約 1%，多為輕度可回復
新發糖尿病 每 255 人吃 4 年多 1 人
橫紋肌溶解 每 10 萬人年 1~3 人
記憶力變差：試驗中未發現增加

其他降膽固醇藥

Ezetimibe 整體與安慰劑相近
PCSK9 針劑 注射部位反應 2~5%
Bempedoic acid 痛風約 3%
(安慰劑約 2%)、膽結石略增
魚油高劑量 心房顫動、出血略增

重要：試驗顯示大多數「statin 引起的肌肉痛」其實不是藥造成的。不舒服請回診討論，不要自行停藥。

多久追蹤一次？

先做生活調整 3~6 個月後驗血脂
開始 statin 6~8 週後驗血脂
開始或加量 3 個月內驗肝功能
已達標 每 6~12 個月追蹤

飲食怎麼選？

多選 蔬菜水果、全穀、燕麥、大麥
豆類與豆製品、魚、無調味堅果、橄欖油
少吃 肥肉、加工肉、奶油、全脂乳
油炸與酥皮、反式脂肪、椰子 / 棕櫚油、含糖飲



出現這些情況，請提早聯絡醫療團隊

明顯肌肉痠痛或無力 | 深色尿 | 皮膚或眼白變黃 | 懷孕或準備懷孕

提醒：血脂達標不代表可以停藥；是否調整或停用，一律由醫師依追蹤結果決定。

資料來源（查核至 2026-09）：

2025 台灣血脂管理臨床路徑共識；2024 台灣心臟學會 ASCVD 初級預防指引；

2026 ACC/AHA 血脂異常指引；Cholesterol Treatment Trialists 統合分析。本單張供衛教使用，不取代個別診療。

© 2026 林祐騰醫師 編製 本單張僅供臨床衛教使用，未經同意請勿重製、改作或作商業用途。